

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098701-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: TEREZINHA DA COSTA GONZO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA PARA MARCAÇÃO DE PRIMEIRA CONSULTA INICIAL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA. GRAVIDADE DA DOENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar, de forma solidária, dentro dos atributos de cada ente, disponibilizarem os réus à parte autora a 1ª consulta ambulatorial em oncologia, confirmando a decisão do evento 16. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, informe ao juízo de origem o teor desta decisão e arquivem-se os autos com baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5098701-96.2024.4.02.5101

510015467111 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098701-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: TEREZINHA DA COSTA GONZO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência tempestivamente interposta contra decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida nos autos nº 5093500-26.2024.4.02.5101, consistente no agendamento de consulta em ambulatório de oncologia e a prestação do tratamento médico adequado.

A petição inicial narra que em **09/09/2024** a Sra. Terezinha da Costa Gonzo recebeu o diagnóstico de **"Out neoplasias comport incerto ou desconhecido tecidos linfáticos hematopoiéticos e tecidos correlatos (CID 10 D-47)"** e que em **01/11/2024** foi inserida no Sistema Estadual de Regulação (SER) para consulta em **Ambulatório 1ª vez - Hematologia (Oncologia)**. Todavia, essa consulta ainda não teria ocorrido.

Aduz que, de acordo com o art. 2º da Lei nº 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico.

Ao apreciar o requerimento de tutela de urgência, o Juízo de origem assim decidiu (evento 3, DESPADEC1):

"A autora requer concessão da tutela provisória de urgência, para que os réus, providenciem CONSULTA EM ONCOLOGIA em até 72 horas, com atendimento integral oportuno.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Intime-se e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias, devendo ainda carrear aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, cumprindo assim a norma do art. 11 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Manifeste-se também, na mesma oportunidade, quanto à caracterização de litispendência ou coisa julgada de que tenha conhecimento.

Ainda, diante dos princípios contidos no art. 2º da Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995, subsidiariamente aplicada (art. 1º da Lei nº 10.259/2001), notadamente os princípios da celeridade e da economia processual, a parte ré, no mesmo prazo, apresentará proposta de transação por escrito, se for do seu interesse, o que não significará nenhuma admissão de culpa nem será levado em consideração num possível julgamento de mérito. Havendo proposta, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, vindo os autos imediatamente conclusos para homologação do acordo, se for o caso.

Venham conclusos para sentença de mérito ou terminativa, não havendo proposta de acordo."

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

VOTO

Em sede de Juizado Especial Federal, a medida de urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

Adequada, portanto, a via eleita para impugnar o indeferimento da tutela de urgência requerida no processo originário.

A tutela de urgência é medida excepcional, uma vez que é realizada mediante cognição sumária, devendo o juiz aplicar tal medida com parcimônia, restringindo-a aos casos em que se constate, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que é dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação, conforme artigo 196 da CF.

No tocante à determinação judicial de antecipação de consulta e tratamento médicos, por ser tratar de medida extraordinária, imprescindível se afigura a demonstração de absoluta gravidade do caso concreto, sob pena de preterir os demais usuários do Sistema Único de Saúde que também se encontram aguardando, em lista de espera.

Assim, em casos envolvendo o direito à saúde, a jurisprudência se mostra cautelosa, para evitar que aqueles que ingressam no Poder Judiciário recebam tratamento privilegiado em relação aos demais usuários do SUS, que também aguardam em fila, em situação também gravosa.

Conforme já relatado, a autora, de 77 anos de idade, foi diagnosticada com Tumores do Tecido Ósseo e Conectivo, necessitando de acompanhamento médico específico na área de oncologia, que aparentemente não vem sendo prestado pelo Poder Pública nos termos da lei.

Veja-se que, de acordo com o parecer técnico do NAT-JUS emitido no caso concreto (evento 14, PARECER1), a consulta médica em hematologia/oncologia é coberta pelo SUS e está indicada ao tratamento do quadro clínico da autora.

Constam do parecer técnico, ademais, as seguintes informações:

No intuito de verificar o correto encaminhamento da Autora aos sistemas de regulação, foi realizada consulta ao Sistema Estadual de Regulação (SER), onde foi identificada solicitação de consulta em **Ambulatório 1ª vez – Hematologia (Oncologia)**, inserida em 01/11/2024 pela Clínica da Família Rinaldo Delamare AP 21 para o tratamento de outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido do tecido linfático, hematopoiético e tecidos correlatos, com situação “**Em fila**”, ocupando atualmente a 134ª posição na lista de espera (ANEXO II).

Assim, entende-se que a via administrativa já está sendo utilizada para o caso em tela, contudo sem resolução do mérito até a presente data.

Por fim, ressalta-se que “*o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único*”³.

Ora, a Lei n.º 12.732/12 preceitua que “*o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único*” (art. 2.º).

Sendo assim, já tendo decorrido prazo muito superior a 60 dias desde que firmado o diagnóstico, a submissão da autora a fila de espera por tempo indeterminado – como no presente caso – viola a norma legal, causando-lhe risco de piora do quadro clínico e até mesmo risco de óbito.

Desse modo, entendo presentes os requisitos constantes do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar, de forma solidária, dentro dos atributos de cada ente, disponibilizarem os réus à parte autora a 1ª consulta ambulatorial em oncologia, confirmando a decisão do evento 16. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, informe ao juízo de origem o teor desta decisão e arquivem-se os autos com baixa na distribuição.